

專業治療

- 1. 骨水泥手術 | 椎體成形術與椎體撐開術
- 2. 微創腰椎手術 | 內視鏡/顯微減壓與固定融合
- 3. 微創頸椎手術 | 人工椎間盤置換與微創融合
- 4. 腕隧道神經鬆解術 | 正中神經減壓治療
- 5. 神經阻斷及疼痛介入治療 | 精準注射與疼痛控制
- 6. 骨質疏鬆與骨折風險治療 | 骨密度管理與藥物治療

神經阻斷及疼痛介入治療 | 精準注射與疼痛控制

透過影像導引，將藥物精準送到疼痛來源，幫助降低神經發炎、緩解疼痛，提供非手術的微創治療選擇。

當腰痛、坐骨神經痛、肩頸痛、手臂麻痛或腳麻劇烈發作時，很多患者會痛到無法翻身、坐立難安，甚至影響睡眠、工作與日常生活。

這時候，口服止痛藥可能效果有限，也可能帶來胃部不適；但症狀又不一定嚴重到需要手術。

這時可以評估是否適合神經阻斷及疼痛介入治療。

這類治療不是單純「打一針止痛」，而是透過 X 光或超音波影像導引，將藥物精準送到神經發炎、關節退化或疼痛來源附近，幫助降低發炎、減少疼痛，也協助判斷真正造成疼痛的位置。

治療重點在於：

精準定位、降低發炎、控制疼痛，讓患者有機會回到日常活動與復健。

常見的介入治療項目

不同疼痛來源，適合的注射位置也不同。

1. 硬膜外神經阻斷術／神經根注射

這類治療常用於椎間盤突出、椎管狹窄、椎間孔狹窄或神經根發炎造成的疼痛。

常見情況包括：

- 急性椎間盤突出
- 坐骨神經痛
- 腰痛延伸到屁股、大腿、小腿或腳底
- 頸椎壓迫造成肩頸痛、手臂痛或手麻
- 影像壓迫位置與症狀分布相符

治療時，醫師會在影像導引下，將藥物送到被刺激或發炎的神經根附近，幫助降低神經水腫與疼痛。

治療反應也能協助判斷：

真正造成症狀的，是不是這一條神經。

2. 脊椎小面關節注射與高頻熱凝治療

有些腰痛或頸部疼痛，不一定是椎間盤或神經根壓迫造成，而是來自脊椎後方的小面關節退化。

常見情況包括：

- 久站、後仰或轉身時腰痛加重
- 肩頸僵硬、轉頭疼痛
- 疼痛以局部痠痛為主
- 不一定合併明顯手麻或腳麻
- 影像顯示小面關節退化

這類患者可以評估小面關節注射。

若是慢性反覆疼痛，且確認疼痛來源與小面關節相關，也可進一步評估高頻熱凝治療，透過調節傳遞痛覺的神經分支，讓疼痛緩解時間有機會延長。

什麼情況適合考慮介入治療？

通常會考慮神經阻斷或疼痛介入治療的情況包括：

- 急性椎間盤突出或坐骨神經痛發作

- 疼痛影響睡眠、走路或工作
- 口服藥物與復健改善有限
- 影像顯示神經壓迫，但尚未出現明顯肌力下降
- 慢性腰背痛或小面關節退化疼痛
- 因高齡、慢性病或個人因素，暫時不適合手術
- 希望先透過非手術方式控制疼痛，爭取復健時間

但如果已經出現明顯無力、走路拖腳、肌肉萎縮、大小便控制異常或脊髓壓迫症狀，就不能只依賴注射治療，應儘快由醫師評估是否需要進一步處理。

神經阻斷及疼痛介入治療的優點

對適合的患者來說，疼痛介入治療具有以下特色：

- 精準定位：在影像導引下，將藥物送到疼痛來源附近
- 傷口極小：多數以針孔方式完成，不需大傷口
- 身體負擔較低：多數處置可在局部麻醉下完成
- 恢復較快：治療後通常短時間觀察即可返家
- 協助診斷：治療反應可幫助判斷真正疼痛來源
- 爭取復健時間：疼痛下降後，較有機會進入運動復健與姿勢調整

但疼痛介入治療不是萬能，也不應該無限制反覆施打。

如果疼痛反覆復發、神經壓迫持續惡化，或已經出現肌力下降，就應重新評估是否有更根本的結構問題需要處理。

文宏裕醫師的治療觀點

很多人以為神經外科醫師只會給病人「開刀」這個選項，其實這是誤解。

臨床上，許多脊椎與神經疼痛，在尚未造成嚴重神經損傷之前，都可以先評估保守治療與精準注射治療。

介入治療的價值，是用較小的負擔，幫助降低急性發炎與疼痛，讓患者重新回到活動與復健。

能透過精準注射與復健改善的，我們不會急著建議手術。

但如果神經壓迫已經造成明顯無力、肌肉萎縮、走路困難，或大小便控制異常，我也會誠懇告知介入治療的限制，協助您選擇更適合的治療方式。

如果腰痛、坐骨神經痛、肩頸痛、手麻或腳麻已經影響生活，就不要只是一直忍耐。讓專業醫師協助您判斷疼痛來源，選擇最適合的治療方式。

不該開的刀，我不開；該開的刀，我做到最好。

手術不是目的，重新回到生活才是目的。

把時間留給生活，不留給疼痛。